

Clasificación sindrómica de las demencias de inicio focal de acuerdo con un criterio topográfico (modificado de Alberca, 2002).

A. Demencias de inicio rostral o frontotemporal
1. Topografía preferentemente frontal neocortical: • Síndrome frontal progresivo o demencia frontal. • Afasia progresiva primaria o síndrome de Mesulam. 2. Topografía preferentemente temporal neocortical: • Prosopagnosia progresiva primaria. • Amusia/agrafia progresiva primaria. • Afasia progresiva fluente o demencia semántica. • Disfunción amnésica progresiva. 3. Topografía preferentemente mesial: • Demencia mesolímbocortical.
B. DEMENCIAS DE INICIO CAUDAL U OCCIPITOPARIETAL:
4. Topografía preferentemente parietal neocortical: • Apraxia progresiva primaria. 5. Topografía preferentemente occipital neocortical: • Agnosia visual asociativa. • Atrofia cortical posterior o disfunción visoespacial progresiva.

- El síndrome frontal progresivo, o la demencia frontal de Brun y Gustafson (1987), hace referencia a un grupo de pacientes que presentan un inicio insidioso y gradualmente progresivo de alteraciones en el comportamiento, en la atención, en la motivación y en otras funciones ejecutivas, constituyendo el único trastorno neuropsicológico primario durante al menos los dos primeros años del inicio de la enfermedad. La relativa preservación inicial del lenguaje, de las habilidades visoespaciales y, especialmente, de las funciones mnésicas son el rasgo central de este síndrome (Mesulam, 2000).
- La prosopagnosia progresiva primaria. En las enfermedades degenerativas primarias la prosopagnosia es infrecuente y, fundamentalmente, se ha descrito en algunos casos de demencia cortical posterior, asociada a otras alteraciones cognitivas. Se caracteriza por una incapacidad para reconocer caras de personas conocidas.
- La demencia semántica. Es un síndrome de instauración insidiosa con afasia fluente progresiva y agnosia visual de los objetos. El defecto principal es una profunda alteración del significado de

las palabras, tanto para denominar como para comprenderlas, con presencia de parafasias semánticas. Contrariamente, los aspectos fonológicos sintácticos del lenguaje están bien conservados. En las fases iniciales del proceso las funciones visoespaciales y visoconstructivas están preservadas, así como la memoria episódica, y sin objetivarse alteraciones conductuales (Mesulam, 2000; Robles-Bayón, 2002).

- La disfunción amnésica progresiva. El rasgo clínico esencial de dicha entidad consiste en la presencia de un déficit progresivo primario de la memoria declarativa que interfiere con las actividades de la vida diaria. Dicho trastorno mnésico no es secundario a un déficit atencional, afectivo, motivacional, lingüístico o trastorno visoespacial. A medida que progresa la amnesia van apareciendo otros déficits cognitivos que posibilitan el diagnóstico de probable enfermedad de Alzheimer en los últimos estadios de la enfermedad (Mesulam, 2000).
- La apraxia progresiva primaria se caracteriza por una apraxia ideomotora, o más frecuentemente melocinética, de inicio insidioso y curso progresivo, sin otras alteraciones cognitivas, y con una actividad funcional reducida (Alberca, 2002). Tiene un inicio asimétrico con torpeza en una extremidad superior que posteriormente afecta a la extremidad superior contralateral y a las extremidades inferiores. Con la progresión de la clínica aparecen síntomas que sugieren una afectación motora subcortical (acinesia, rigidez de extremidades, distonía o parálisis de la mirada vertical) (Habib y colaboradores, 1995).
- La atrofia cortical posterior es un síndrome clínico caracterizado por una afectación progresiva de las funciones visuales complejas en forma de agnosia visual o de alteraciones visoespaciales. Puede aparecer inatención y extinción en un hemicampo e incluso hemianopsia, aparaxia del vestirse y los pacientes desarrollan un síndrome de Balint y de Gerstmann más o menos completos (Benton y colaboradores, 1988; Mesulam, 2000).